

肺癌:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師	病院と共有する情報	病院薬剤師
① 経口TKIの服用時点(エルロチニブは空腹時)・残薬の確認	ドライバー遺伝子・治療ライン (お薬手帳)	① ドライバー遺伝子・PD-L1の結果とレジメンの整合性の監査
② 市販の胃薬・サプリを含めた相互作用の確認	検査値 (肝機能・脂質・好中球数)	② 化学療法の投与量計算、前投薬(葉酸・B12、過敏症予防)の確認
③ 電話フォローで皮疹・下痢・咳・息切れを確認	皮疹・下痢のGrade (トレーシングレポート)	③ ILD・irAE発症時の院内連携(呼吸器・内分泌など)
④ 皮疹・爪囲炎のスキンケア指導と外用薬の使い方	咳・息切れの有無 (電話フォローの結果)	④ 外来化学療法室・導入時の副作用説明
⑤ 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ		⑤ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

CDDP+PEM 点滴・注射	シスプラチン+ペメトレキシド(非扁平上皮)。維持療法はペメトレキシド単剤	3週毎	✓ 葉酸・ビタミンB12の前投与 ✓ 腎機能低下時のNSAIDs併用 ✓ 大量補液
CBDCA+PTX 点滴・注射	カルボプラチン+パクリタキセル(土ペバシズマブ)	3週毎	✓ 過敏症予防の前投薬 ✓ 溶媒のエタノール(運転・飲酒) ✓ 末梢神経障害
オシメルチニブ 経口	80mg 1日1回 連日内服	連日	✓ QT延長薬の併用 ✓ 乾性咳嗽・息切れ(ILD) ✓ 爪囲炎
アレクチニブ 経口	300mg 1日2回 連日内服	連日	✓ 筋肉痛・CK上昇 ✓ 便秘 ✓ 光線過敏(日焼け対策)
ロルラチニブ 経口	100mg 1日1回 連日内服	連日	✓ 脂質異常症(定期的な脂質検査) ✓ 気分・認知の変化 ✓ リファンピシンは併用禁忌
DTX+RAM 点滴・注射	ドセタキセル+ラムシルマブ	3週毎	✓ 発熱性好中球減少(G-CSF予防の検討) ✓ 浮腫 ✓ 口内炎

● 経口
 ● 点滴・注射
 ● 点滴+経口
 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休業日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	ロルラチニブ CYP3A4誘導	処方薬 リファンピシン(抗結核薬)	重篤な肝障害・効果減弱	併用しない。他院の抗結核薬の処方を確認
注意 添付文書 併用注意	ゲフィチニブ・エルロチニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓→効果減弱	市販のH2ブロッカーも確認、服用時間を調整
注意 添付文書 併用注意	オシメルチニブ等・EGFR・ALK阻害薬 CYP3A4誘導	処方薬 カルバマゼピン・フェニトイン・リファンピシン	血中濃度↓→効果減弱	他院の抗てんかん薬・抗結核薬を確認
注意 添付文書 併用注意	エルロチニブ CYP1A2誘導	生活習慣 喫煙	血中濃度↓→効果減弱	喫煙状況を確認し禁煙を支援
注意 添付文書 併用注意	ペメトレキシド 腎排泄の低下	処方薬 市販薬 NSAIDs(市販の解熱鎮痛薬も)	骨髄抑制・粘膜障害↑	投与前後の市販鎮痛薬の使用を聴取
確認 添付文書 用法・用量	ペメトレキシド 前投与の不足	処方薬 葉酸の毎日の服用・ビタミンB12注射	骨髄抑制・粘膜障害↑	葉酸の飲み忘れがないか確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

① 治療開始前	② TKI開始1~4週	③ 化学療法1~2週	④ 治療中はいつでも
“この薬は毎日同じ時間に飲み続けることで効果を保ちます。飲み忘れた時の対応も一緒に確認しましょう”	“顔や胸のニキビのような発疹は、保湿と早めの塗り薬で抑えられます。我慢せず教えてください”	“37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください”	“息切れや空咳が続く時、熱を伴う時は、次の受診を待たずに連絡してください”
✓ 薬局で確認 お薬手帳でドライバー遺伝子・治療ライン、併用薬(胃薬・QT延長薬・CYP3A4関連)	✓ 薬局で確認 電話フォローで皮疹・下痢のGrade、保湿剤・外用薬の使い方	✓ 薬局で確認 電話フォローでnadir期の発熱・口内炎を確認	✓ 薬局で確認 来局ごとに咳・息切れ・発熱、ICIでは倦怠感・口渇・動悸を聴取
△ここに注意 ペメトレキシドは葉酸・B12の前投与を開始済みか	△ここに注意 水様便が1日4回以上増える時は連絡	△ここに注意 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診	△ここに注意 息切れ・空咳・発熱はILDを疑い至急受診